

Lima, 01 de Setiembre de 2025

CARTA N° 0187-2025-SG-UPNW-CP

Dr. Pedro Alejandro Cruzado Puente Director
General de la DIRIS Lima Centro DIRIS Lima
Centro
Av. Nicolás de Pierola 589- Cercado de Lima
Lima.-

ASUNTO: Autorización para aplicación de estudio de campo

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez presentar a las bachilleres de la carrera profesional de Farmacia y bioquímica, Jackeline Daniela Leon Baldeon, con código de matrícula N° 2020105093 y Greisy Vanessa Vallejos Diaz con código de matrícula N° 2021102655, con la finalidad de solicitar se brinde todas las facilidades pertinentes para que pueda aplicar los instrumentos de recolección de datos a 120 pacientes de los diversos centros de salud de Lima que son atendidos con el diagnóstico de Tuberculosis, mayores de 18 años.

Toda la información que solicite las tesis **Jackeline Daniela Leon Baldeon y Greisy Vanessa Vallejos Diaz** para la elaboración de su proyecto de investigación denominado: **“FACTORES RELACIONADOS Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PERSONAS CON TUBERCULOSIS EN CENTROS DE SALUD. LIMA CENTRO.2025”** dirigido por la asesora de tesis Mg. Luz Fabiola Guadalupe Sifuentes De Posadas, para la obtención del título profesional de Químico Farmacéutico.

Agradeciendo por anticipado su autorización a las tesis para que logren su propósito, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal.

Atentamente,



Firmado digitalmente por: Khristian
Vigil Vega DNI: 44025157
RUC: 20466246370
Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 01/09/2025
Hora: 18:58:14



Universidad
Norbert Wiener

Khristian Vigil Vega

Secretario General

Universidad Privada Norbert Wiener S.A.



**Universidad
Norbert Wiener**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA ACADÉMICO DE FARMACIA Y
BIOQUÍMICA**

**FACTORES RELACIONADOS Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN
PERSONAS CON TUBERCULOSIS EN CENTROS DE SALUD. LIMA
CENTRO. 2025**

PROYECTO DE TESIS

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE QUÍMICO FARMACÉUTICO

AUTOR:

LEON BALDEON JACKELINE DANIELA
CODIGO ORCID:0009-0004-1839-2214

VALLEJOS DIAZ, GREISY VANESSA
CODIGO ORCID:0009-0008-4798-2562

ASESOR

Mg. GUADALUPE SIFUENTES LUZ FABIOLA
CODIGO ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4694-9054>

LIMA-PERÚ
2025

INDICE

INDICE DE TABLAS	4
CAPITULO I: EL PROBLEMA	5
1.1 Planteamiento del problema	5
1.2 Formulación del Problema	8
1.2.1. Problema General	8
1.2.2. Problemas Específicos	8
1.3 Objetivos de la investigación	8
1.3.1. Objetivo General	8
1.3.2. Objetivos Específicos	9
1.4 Justificación de la investigación	9
1.4.1 Teórica	9
1.4.2. Metodológica	10
1.4.3. Práctica	10
1.5 Limitaciones de la investigación	11
1.5.1 Temporal	11
1.5.2. Espacial	11
1.5.3. Población o unidad de análisis	11
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO	12
2.1. Antecedentes	12
2.1.1. Antecedentes Internacionales	12
2.1.2. Antecedentes Nacionales	14
2.2. Bases Teóricas o Científicas	16
2.3. Formulación de hipótesis	20
CAPITULO III: METODOLOGÍA	22
3.1. Metodo	22
3.2. Enfoque	22
3.3. Tipo de la investigación	22
3.4. Diseño de la investigación: no experimental	22
3.5. Población, muestra y muestreo	23

	4
3.6. Variables y operacionalización	24
3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	29
3.7.1. Técnica	29
3.7.2. Descripción de instrumentos	29
3.7.3. Validación	29
3.7.4. Confiabilidad	30
3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos	30
3.9. Aspectos éticos	31
4.2. Presupuesto	34
ANEXOS	46
ANEXO. Matriz de consistencia	47

INDICE DE TABLAS

Tabla 1	Variable 1: Factores relacionados al tratamiento	18
Tabla 2	Variable 2: Adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis	20
Tabla 3	Cronograma de actividades	26
Tabla 4	Presupuesto	27

CAPITULO I: EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema

La tuberculosis se aloja en diferentes órganos, pero con más frecuencia en los órganos pulmonares. La tuberculosis puede ser mortal si no se trata adecuadamente (1). Al año se registran una estadística de diez millones de tuberculosis activa a nivel mundial y mil setecientos veintidós millones de personas a nivel de Latinoamérica. Si un paciente no es tratado de manera inmediata, es probable que contagie la infección a entre diez y quince personas más por año. (2)

Esto afecta principalmente a los países en desarrollo, constantemente a las personas de entre 20 y 44 años que son quienes sufren el mayor número de bajas. La resistencia a la medicación ha hecho que el tratamiento de la tuberculosis sea cada vez más difícil en los últimos tiempos. Que el tratamiento sea exitoso; depende de la adherencia de los pacientes. (3)

Los pacientes que suspenden la medicación antes del periodo de tiempo prescrito pueden desarrollar resistencia a los fármacos, lo que puede dificultar la continuación de la medicación.

Por lo tanto, es fundamental que los pacientes sigan el tratamiento completo recomendado por el profesional sanitario y reciban la ayuda necesaria para ello. (4)

En Perú, el 59,3% de todos los casos fueron notificados por la Región Callao y Lima Metropolitana. (5)

Controlar la tuberculosis a nivel de los establecimientos de salud (C.S) es complicado por la gran cantidad de contagiados con la enfermedad y que no se adhieren al tratamiento; llegando a complicar su recuperación y aumentar el riesgo de resistencia bacteriana, agravando el problema de salud en los pacientes positivos a la enfermedad. (6)

Debido a la gran población de Lima y a su rápida expansión; un paciente que abandona la terapia corre el riesgo de infectar entre diez y quince, personas al año. (7) Por lo tanto, si se mantienen las bajas tasas de adherencia y abandono en un entorno de hacinamiento, las complicaciones de la tuberculosis se desarrollarán y propagarán más rápidamente, provocando una mortalidad temprana y la muerte. (8)

La elevada tasa de abandono (11,2%) supera el umbral del 5% establecido por la OMS/OPS, que consideran que cuando la tasa de abandono es superior al 5%, existe preocupación de la calidad de atención del servicio sanitario. (9). Con este trabajo se buscará identificar la relación entre dos variables, las cuales son la adherencia y los factores relacionados al tratamiento, a fin de tomar medidas para reducir la incidencia de esta enfermedad. Debido a la importancia del cumplimiento del tratamiento, es imperativo investigar, los factores relacionados y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud. Lima .2025. (10)

1.2 Formulación del Problema

1.2.1. Problema General

¿Qué relación existe entre los factores relacionados y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud. Lima Centro. 2025?

1.2.2. Problemas Específicos

- ¿Qué relación existe entre el sistema de asistencia sanitaria y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud?
- ¿Qué relación existe entre el tratamiento y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud?
- ¿Qué relación existe entre el paciente y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo General

Determinar qué relación existe entre los factores relacionados y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Determinar la relación entre los factores relacionados al sistema de asistencia sanitaria y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud.
- Determinar la relación entre los factores relacionados al tratamiento y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud.
- Determinar la relación entre los factores relacionados al paciente y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud.

1.4 Justificación de la investigación

1.4.1 Teórica

Esta investigación se fundamenta en diversas evidencias proveniente de búsquedas previas,

las cuales serán examinadas y comparadas en enfoques teóricos. Por lo tanto, se va a revisar los principales conceptos con el objetivo de interpretar los datos recolectados sobre las variables, se realizó el trabajo de investigación con la finalidad de identificación, tanto del grado de adherencia y la relación con los factores relacionados, de los pacientes positivos a la enfermedad, que son atendidos en diferentes establecimientos de Salud. Lima Centro .2025. Los resultados obtenidos podrán aportar información valiosa para futuras investigaciones que trabajen con variables similares. (11)

En nuestro país hay mucha desinformación sobre la enfermedad de la tuberculosis a pesar de las medidas para prevenir y controlar dicha enfermedad, esto no ha sido suficiente para que los pacientes utilicen los fármacos adecuadamente, un factor muy común en el uso del tratamiento para la TBC; dado que este es un tema que nos afecta como profesionales de la salud, es importante profundizar en este tema, debido a las recaídas y el abandono del tratamiento. (12)

1.4.2. Metodológica

Desde un enfoque metodológico, se utilizará los métodos habituales para confrontar la problemática hallado entre los factores relacionados y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud, al demostrarse si existe una relación entre ambas variables.

En este estudio, se indagará evidencias científicas , para determinar la relación entre dos variables tanto de la adherencia y los factores relacionados en personas con tuberculosis, para lo cual se va considerar, a los pacientes medicados para la enfermedad de TBC, en diferentes establecimientos de Salud de la ciudad de Lima, encuestándolos y pidiendo información al médico de esa área para obtener datos de cada paciente, saber el tratamiento respectivo que reciben para

tratar la tuberculosis y aplicar “el cuestionario Martin Bayarre- Grau (MBG)”, lo que permitirá contribuir a fortalecer el conocimiento de los pacientes sobre su enfermedad, mejorando su actitud ante el tratamiento y facilitar el cumplimiento del mismo, promoviendo así una mejor calidad de vida del paciente.(13)

1.4.3. Práctica

El propósito de este trabajo de investigación fue un análisis basado en la adherencia y los factores relacionados al tratamiento en personas con tuberculosis, que por tanto desencadena en un uso inadecuado de los medicamentos para dicha enfermedad, con la finalidad de desarrollar actividades que promuevan que los pacientes tengan adherencia a la medicación y disminuir así, la ocurrencia en fracasos terapéuticos para recuperación de la salud del paciente. (14)

1.5 Limitaciones de la investigación

1.5.1 Temporal

El desarrollo del trabajo de investigación se realizará en el año 2025.

1.5.2. Espacial

El presente trabajo se ejecutó en diferentes establecimientos de Salud de Diris Lima Centro

1.5.3. Población o unidad de análisis

Personas diagnosticadas con la enfermedad tuberculosis.

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

2.1.1. Antecedentes Internacionales

Suescun et al. (15) en el año 2024 en Colombia. Con el Objetivo “Determinar los factores relaciones que influyan la adherencia terapéutica en personas con tuberculosis”, se aplicó una Investigación descriptiva, no experimental y se usó como fuente de datos registrado en la central a través del programa departamental de tuberculosis y Sivigila. Participaron 402 personas. Se obtuvo como resultado que la adherencia farmacológica para TBC fue 96,5% y la no adherencia de 3,5%, 91,2% pertenecen a diversos conjuntos de la población, el 7,5% pertenece a las personas en prisión y las comorbilidades como la de VIH fue un 4,2% de mayor presencia. El sexo masculino son pacientes con mayor probabilidad de abandonar el tratamiento. Se concluyó mostrando una correlación estadística significativa entre las variables; factores relacionados y la adherencia farmacológica.

Muhammad y Cica. (16) en el año 2023 en Indonesia. Con el Objetivo “Identificar la correlación entre el entendimiento y la actitud hacia la adherencia terapéutica en personas positivo a TBC pulmonar”, se aplicó una Investigación cuantitativa, no experimental, analítica y de corte transversal. Participaron 43 personas. Se utilizaron dos cuestionarios como instrumentos de recopilación de datos. Se obtuvo un resultado de 88.37% presentó un grado de conocimiento alto y el 11.63% nivel intermedio. El 95.34% tuvo actitudes positivas hacia la adherencia al tratamiento y solo el 4.7% mostró actitudes negativas. Se concluyó mostrando una evidencia de correlación

positiva y significativa entre conocimientos y actitudes hacia la adherencia al tratamiento ($p = 0.609; < 0.05$).

Sánchez A. (17) en el año 2023 en México. Con el Objetivo de “Establecer los factores asociados a la adherencia al tratamiento en personas con TBC pulmonar en Cancún”, se aplicó un análisis descriptivo, transversal y analítico, se utilizó el cuestionario de SMAQ, para evaluar adherencia terapéutica. Obtuvimos como resultado que el 82.14% de los estudios reportó fueron adherentes al tratamiento, dentro de las comorbilidades asociadas, con más frecuencia fue la diabetes mellitus tipo 2 con 50%, seguidamente las enfermedades al hígado con 14.28%, la HTA 14.28% entre otras. Se concluyó que los pacientes que tienen educación básica y de sexo masculino y con enfermedades mórbidas tienen mayor riesgo para no adherirse al tratamiento.

Figuerola et al. (18) en el año 2021 en Colombia. Con el Objetivo de “Establecer el grado de conocimientos y actitudes asociados a la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis pulmonar”, se aplicó una revisión sistemática de literatura, basada en 34 artículos científicos obtenidos de revistas indexadas y repositorios universitarios. Se halló como resultado que el 54% de los estudios, reportó bajo grado de conocimientos, especialmente en países africanos. Actitudes negativas como la indiferencia y el rechazo predominaron en África (61%), mientras que la aceptación fue más común en América y Europa (67%). Se concluyó que los conocimientos y actitudes están directamente asociados con la detección, prevención y adherencia al tratamiento de la tuberculosis pulmonar ($p = 0.711; < 0.05$).

Rasaq et al. (19) en el año 2021 en Nigeria. Con el Objetivo “Determinar los conocimientos y actitudes sobre la adherencia al tratamiento en individuos con TBC pulmonar”, la metodología del estudio es mixto, transversal; con una población de 140 personas. Se utilizó un cuestionario para recolectar los datos. Se obtuvo como resultados el 97% tuvo conocimientos moderados; solo el 3% tuvo conocimientos bajos. Solo el 4% mostró actitudes de adherencia, lo cual se relacionó con inaccesso a centros de salud (55%) y baja educación (16%). El 25% culminó el tratamiento, el 10% no terminó el tratamiento y el 7.8% falleció. Se concluyó que existe una asociación positiva y significativa entre las variables ($p = 0.827$; < 0.05), afectada por factores sociales y estructurales.

2.1.2. Antecedentes Nacionales

Quispe D. Ríos I. (20) en el año 2024 en Pacasmayo. Con el objetivo “Establecer los factores de riesgo asociados a pacientes que abandonaron el tratamiento de tuberculosis en la Red de Salud Pacasmayo”, se aplicó un conjunto de métodos de estudio cuantitativo, descriptivo-analítico y no experimental. La muestra incluyó 23 personas con tuberculosis, evaluados mediante un cuestionario estructurado sobre aspectos sociodemográficos, sociales e institucionales. Se obtuvo como resultado la mayoría de los pacientes eran hombres (78.3%), de 30 a 59 años (65.2%), solteros (52.5%), con educación primaria (34.8%), procedentes de zonas rurales (60.9%) y con ingresos menores a S/ 1,025 (56.5%). En el ámbito social, predominó la falta de apoyo de sus familiares (56.5%) y de la sociedad (78.3%), así como la estigmatización (69.6%) y el consumo de alcohol (56.5%). A nivel institucional, el 91.3% manifestó una óptima relación con el personal del centro de salud y el 95.7% percibió eficacia en el tratamiento. Se concluyó que encontraron

como factores de riesgo significativos para el abandono del tratamiento: el sexo masculino ($p=0.008$), origen rural ($p=0.049$), ingesta de alcohol ($p=0.001$), falta de apoyo de sus parientes ($p=0.019$), falta de apoyo sociedad ($p=0.016$) y presencia de efectos negativos ($p=0.005$).

Quispe J. (21) en el año 2024 en Lima. Con el Objetivo “Establecer el vínculo entre el grado de conocimiento y la actitud frente a la adherencia terapéutica en personas con tuberculosis pulmonar”, se aplicó una metodología de investigación cuantitativa, de tipo aplicada y correlacional; diseño no experimental. Se utilizó de modo hipotético-deductivo con una muestra de 80 pacientes. Se aplicaron dos cuestionarios estructurados para evaluar ambas variables. Se obtuvo como resultados el 56.2% de los participantes presentó un nivel medio de conocimiento. En cuanto a la disposición, el 41.3% dio una aceptación hacia el tratamiento, el 40% indiferencia y el 18.7% rechazo. El factor de correlación de Spearman fue 0.813 ($p = 0.000$), lo que indica una asociación óptima y relevante entre ambas variables. Se concluyó la existencia de una correlación alta y relevante del conocimiento y la actitud hacia la adherencia farmacológica en pacientes infectados con TBC pulmonar.

Minchán J., Sandoval M. (22) en el año 2023 en Lima. Con el Objetivo “Establecer los factores asociados a la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud San Martín de Porres Confraternidad. Lima. 2023”, se aplicó una metodología de enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, transversal y correlacional. La población estaría conformada por 44 pacientes positivos a tuberculosis atendidos durante el mes de abril de 2023. Se emplearon cuestionarios de recolección de datos para calificar los factores asociados y una escala tipo Likert validada para medir la adherencia al tratamiento. Se obtuvo como resultados que la gran parte de pacientes tenía entre 30 y 59 años (38,6%), eran varones (70,4%) y contaban con educación secundaria (52,2%). El 56,8% no consumía tabaco, el 63,6% sí consumía alcohol y

el 77,2% no consumía drogas. El 50% percibió un trato regular por parte del personal de salud. En cuanto a la adherencia terapéutica, el 45,4% mostró adherencia favorable, el 36,3% adherencia indiferente y el 18% adherencia desfavorable. Se concluyó que existe asociaciones estadísticamente significativas entre la adherencia al tratamiento y los factores de edad ($p=0,000$), sexo ($p=0,024$), ingesta de alcohol ($p=0,011$) y conducta del personal de salud ($p=0,032$).

Berrocal N., Sánchez J. (23) en el año 2023 en Lima. Con el Propósito “Determinar la correlación entre el uso de tecnologías de comunicación e información y el grado de adherencia terapéutica de tuberculosis en dos establecimientos de salud de la DIRIS Lima Norte”, se aplicó una metodología de estudio cuantitativo, transversal, descriptivo y no experimental. La muestra está integrada por 30 personas con TBC que recibe su medicación de forma digital, en los dos centros de salud seleccionados. Para recopilar información de datos se emplearon el cuestionario BMG para evaluar la adherencia y un cuestionario sobre la utilización del TIC en salud. Se obtuvo como resultado una relación positiva entre el grado de adherencia y el empleo de TIC ($r = 0,612$; $p = 0,000$). El 66,7% de los pacientes presentó adherencia total, mientras que el 30% mostró un nivel alto en el manejo del TIC. Se concluyó que el empleo de tecnologías de comunicación se relaciona positivamente con el grado de adherencia a la medicación en individuos con TBC evidenciando la importancia de las TIC con el seguimiento efectivo del tratamiento en contextos de atención virtual.

2.2. Bases Teóricas o Científicas

2.2.1. Tuberculosis

2.2.1.1. Definición

El *Mycobacterium tuberculosis* (MTB), afecta mayormente a los pulmones, y en otros casos daña al sistema nervioso central, linfático, gastrointestinal, la piel y los huesos; la

enfermedad (TBC) tiene como agente patógeno a la bacteria llamada Bacilo de Koch. (24)

2.2.1.2. Epidemiología

En la población mundial un tercio de las personas está infectada. Si no se avanza en la detección y el tratamiento, se prevé que esta terrible situación se prolongue hasta 2030. Existen muchos casos en Lima Metropolitana con todos sus distritos. (25)

2.2.1.3. Signos y síntomas

Son: tos productiva durante dos semanas, fiebre con sudores mayormente en la noche y pérdida de peso. La fiebre es el síntoma constitucional más frecuente; empieza siendo leve, pero se agrava a medida que la enfermedad empeora. La fiebre suele empezar a última hora de la tarde y a veces no va acompañada de síntomas evidentes. Los clásicos "sudores nocturnos" se asocian a la defervescencia y suelen producirse al dormir. (26)

2.2.1.4. Tratamiento

A través de la Estrategia Nacional Antituberculosa, el Ministerio de Salud de Perú cubre íntegramente el coste del tratamiento tras un diagnóstico positivo de la enfermedad, y abastecer de los medicamentos necesarios en la institución médica; el paciente también será sometido a una evaluación exhaustiva que incluye pruebas auxiliares y consultas con expertos en campos como nutrición, psiquiatría, trabajo social y otros. (27)

Los principales medicamentos o núcleo del tratamiento antituberculoso, la isoniazida y la rifampicina, deben probarse rápidamente en el paciente para poder iniciar el tratamiento. El esquema consta de 2 periodos, después un periodo de cuatro meses de administración de isoniazida y rifampicina (2HREZ/4H3R3) (28)

Cualquier incidente relacionado con los fármacos utilizados en la terapia que imposibilite la continuación del tratamiento se conoce como reacción adversa a un medicamento, y puede producirse de varias maneras. Las reacciones indeseables y que se produzcan interacciones entre fármacos pueden repercutir considerablemente en el plan de tratamiento, que suele desembocar en la interrupción de la medicación. (29)

2.2.2. Adherencia Terapéutica

2.2.2.1. Definición

En 2017 se definió la adherencia, a que una paciente siga las recomendaciones del tratamiento, indicadas por el médico. Es cómo se comporta el paciente en relación con los consejos del equipo médico. También sugiere que el paciente está dispuesto a poner en práctica los consejos de forma responsable, a mejorar su calidad de vida y a dar su consentimiento a las pruebas adicionales que puedan ser necesarias. La no adherencia al tratamiento, por tanto, es el hecho de no seguir las pautas de tratamiento prescritas. (30)

Por lo tanto, a través de un periodo extenso se ha planteado una gama de estrategias para avanzar en la adherencia. Estas estrategias incluyen medidas de reducción del tratamiento, iniciativas educativas e informativas, apoyo familiar y social, y refuerzo conductual a nivel de grupo. (31)

2.2.2.2. Factores de la adherencia terapéutica

❖ Factores relacionados al sistema de asistencia sanitaria.

Éstas pueden ser la inexistencia de planes de seguro médico, personal médico con poca experiencia, la motivación, escasa retroalimentación sobre el rendimiento, técnicas de interrogatorio deficientes, inadecuadas habilidades de seguimiento y formación de usuarios

que contribuyen al subdesarrollo de los servicios sanitarios. (32)

❖ **Factores relacionados con el tratamiento.**

Entre ellos tenemos el tiempo que tarda en empezar a hacer efecto el medicamento, las dosis y la frecuencia, el historial de fracasos terapéuticos, la variación habitual en el curso del tratamiento, los beneficios y los inconvenientes del uso de los fármacos (33)

❖ **Factores relacionados al paciente.**

Entre los principales están, los sentimientos de angustia por el miedo de sufrir daños adversos, el miedo, la sensación de necesidad de tratamiento, la negación de la enfermedad, la incredulidad del diagnóstico. (34)

2.2.2.3. Importancia de la adherencia terapéutica

Los pacientes pueden cansarse del tratamiento o perder el interés por continuar la terapia. Si un paciente no completa el tratamiento, corre el riesgo de empeoramiento de su enfermedad, contagiarla; y morir por un tratamiento demasiado agresivo. (35)

La NTS 221-MINSA/DGIESP-2024

La Norma Técnica de Salud para la Prevención, Tratamiento y Control de la Tuberculosis en Perú, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 894-2024/MINSA. Esta norma establece las intervenciones sanitarias para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la tuberculosis, incluyendo un enfoque en la atención a grupos vulnerables y el abordaje de los

determinantes sociales de la salud

- Finalidad:

Contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad por tuberculosis en Perú, buscando mejorar la calidad de atención y reducir la transmisión de la enfermedad en la comunidad.

- Ámbito de aplicación:

Se enfoca en la prevención y control de la tuberculosis en todo el país, con especial atención a grupos de riesgo y poblaciones vulnerables.

- Contenido principal:

- Prevención: Acciones para evitar la infección.
- Detección y diagnóstico: Uso de tecnologías para identificar casos y asegurar un diagnóstico preciso.
- Tratamiento: Implementación de esquemas de tratamiento eficaces, incluyendo opciones más cortas, especialmente para poblaciones vulnerables.
- Rehabilitación: Actividades para la recuperación de las personas afectadas.
- Determinantes sociales: Aborda los factores sociales que afectan la salud con un enfoque intersectorial y de gestión territorial.

Factores que influyen en la adherencia

- Factores socioeconómicos y demográficos:

Vivienda precaria, bajos ingresos, bajo nivel educativo y trabajos inadecuados pueden dificultar el seguimiento del tratamiento.

- Problemas de salud y psicosociales:

El alcoholismo, el abuso de drogas y otros problemas psicosociales pueden afectar negativamente la adherencia.

- Efectos secundarios de la medicación:

Los efectos adversos pueden llevar a que los pacientes dejen de tomar los medicamentos.

- Apoyo familiar y social:

El apoyo de la familia y la comunidad es un factor importante que puede mejorar la adherencia.

- Adherencia al tratamiento:

El abandono del tratamiento, influenciado por factores como los efectos secundarios, el costo, la percepción del paciente y la falta de apoyo, puede llevar al fracaso terapéutico.

- Marco normativo:

Se aprueba mediante Resolución Ministerial N° 894-2024/MINSA, según se detalla en la información de la Plataforma del Estado Peruano y la publicación en El Peruano

En 2024, se han implementado nuevos tratamientos para la tuberculosis que incluyen regímenes orales de duración más corta y más seguros para la tuberculosis multidrogorresistente (TB-MDR), como el esquema BPaLM (bedaquilina, pretomanida, linezolid y moxifloxacina). Para la tuberculosis sensible (TB-DS), se están evaluando y utilizando opciones de tratamiento de cuatro meses en lugar de seis, como un régimen de isoniacida, rifapentina, pirazinamida y moxifloxacina.

Tratamientos para la tuberculosis multidrogorresistente (TB-MDR)

- Esquema BPaLM:

Este régimen oral de cuatro medicamentos ha demostrado ser más seguro, más eficaz y más rápido que los tratamientos anteriores para la TB-MDR, que pueden durar hasta 18 meses e incluir

inyecciones.

- Duración:

Se están implementando esquemas acortados, de hasta 9 meses, que evitan las inyecciones dolorosas y los efectos secundarios.

Tratamientos para la tuberculosis sensible (TB-DS)

- Régimen de 4 meses:

Se está considerando un régimen acortado de cuatro meses (en lugar de seis) para adultos y adolescentes con TB pulmonar sensible.

- Composición del régimen:

Este nuevo régimen incluye dos meses de isoniacida, rifapentina, pirazinamida y moxifloxacin, seguidos de dos meses de isoniacida, rifapentina y moxifloxacin.

- Beneficios:

Este esquema ofrece una opción más corta que podría mejorar la adherencia, reducir costos y disminuir la toxicidad ocular asociada al etambutol, que no se incluye.

Consideraciones importantes

- Recomendaciones de la OMS:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda activamente estos regímenes acortados, tanto para TB-MDR como para TB-DS, para mejorar la seguridad y eficacia del tratamiento, especialmente en entornos con recursos limitados.

- Aprobación en países:

Varios países, como Perú, han adoptado formalmente estos tratamientos acortados para pacientes

con TB-MDR, facilitando el acceso a opciones más modernas y efectivas.

CENTROS DE SALUD DONDE SE APLICARÁ EL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

1. C.S. BREÑA
2. C.S. SAN MIGUEL
3. C.S. JESUS MARIA
4. C.S. LINCE
5. C.S. SAN ISIDRO
6. C.S. MAX ARIAS SCHREIBER
7. C.S. EL PINO
8. C.S. EL PORVENIR - MATERNO
9. C.S. SAN COSME
10. C.S. SAN LUIS
11. C.S. CHACARILLA DE OTERO
12. C.S. MEDALLA MILAGROSA

2.3. Formulación de hipótesis

2.3.1. Hipótesis general

- Existe relación entre los factores relacionados y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud.
- No existe relación entre los factores relacionados y la adherencia al tratamiento en

personas con tuberculosis en centros de salud.

2.3.2. Hipótesis específicas

HE1

Hi: Existe relación entre los factores relacionados al sistema de asistencia sanitaria y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud.

Ho: No existe relación entre los factores relacionados al sistema de asistencia sanitaria y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud.

HE2

Hi: Existe relación entre los factores relacionados al tratamiento y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud.

Ho: No existe relación entre los factores relacionados al tratamiento y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud.

HE3

Hi: Existe relación entre los factores relacionados al paciente y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud.

Ho: No existe relación entre los factores relacionados al paciente y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud.

CAPITULO III: METODOLOGÍA

3.1. Método

Hipotético deductivo ya que solo aporta conocimientos sobre el problema planteado. Se aplica a una serie de premisas o de hipótesis de un análisis. (36)

3.2. Enfoque

Cuantitativo, según Hernández Sampieri (2018). Debido a la utilización de estadística para encontrar patrones de comportamiento y recopilar datos para evaluar hipótesis que se basan en medidas numéricas (37)

3.3. Tipo de la investigación

Este trabajo es básico; no es necesario evaluar los hallazgos teóricos con problemas del mundo real. Con los resultados se puede formular una hipótesis que será útil para elaborar recomendaciones farmacéuticas para los programas de tratamiento de la tuberculosis.

3.4. Diseño de la investigación

No experimental porque se proponen correlaciones potenciales que podrían investigarse sin modificar ninguna variable. el enfoque del trabajo investigado fue no experimental. Los acontecimientos se observaron en su entorno natural con la expectativa de que repercutieran en las variables.

3.4.1. Corte

Transversal porque se recopila información a través del tiempo en un solo punto. Estos estudios son transversales que examinan una o más variables, en este caso en un momento dado y no a través del tiempo. (38)

3.4.2. Nivel o alcance

Correlacional por lo que es fundamental, en medir dos variables y establecer una relación de tipo estadística entre ellas.

3.5. Población, muestra y muestreo

Población

En este informe investigado, la población se encuentra constituida por 120 individuos con medicación para la tuberculosis, atendidos por los centros de Salud de Lima Centro.2025.

Criterios de inclusión

Pacientes atendidos en Centros de Salud de Diris Lima Centro. 2025 con diagnóstico de tuberculosis, que son mayores de edad.

Criterios de exclusión

Pacientes encuestados, que no hayan completado la encuesta ó que realicen doble respuesta.

Muestra

Debido a que la población es relativamente reducida, se ha considerado no usar muestra.

Muestreo

Debido a que se va a trabajar con toda la población, no se va a utilizar ninguna técnica de muestreo.

3.6. Variables y operacionalización

FACTORES RELACIONADOS Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PERSONAS CON TUBERCULOSIS EN CENTROS DE SALUD. LIMA CENTRO. 2025

Tabla 1

Variable 1: Factores relacionados al tratamiento

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN	ESCALA VALORATIVA
FACTORES RELACIONADOS AL TRATAMIENTO	Desempeñan un papel en el cumplimiento terapéutico, desafiando la sabiduría convencional que afirma que el cumplimiento terapéutico es responsabilidad exclusiva del paciente (39)	Incluyen características socioeconómicas, el sistema de asistencia sanitaria, así mismo del tratamiento y el paciente (40)	Sistema de asistencia sanitaria Tratamiento Paciente	Conocimiento de los médicos Competencia profesional de los médicos. Eficiencia en el abastecimiento de los medicamentos. Dificultades del tratamiento. Dosis y su frecuencia Las reacciones adversas que ocurren. Motivación Apoyo Gestión Ideales	Ordinal	Alta Media Baja

Nota. - Se muestra la variable: Factores relacionados y adherencia al tratamiento. Se detalla su definición conceptual y operacional, así como sus dimensiones; indicadores; escala de medición y; escala valorativa.

Tabla 2

Variable 2: Adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUA L	DEFINICIÓN OPERACIONA L	DIMENSIONE S	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN	ESCALA VALORATIVA
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PERSONAS CON TUBERCULOSIS	La forma en que un paciente ingiere su medicación se conoce como adherencia terapéutica. Es la medida en que el paciente toma sus medicaciones y cuida su estilo de vida (41)	La medición de conductas explícitas que permiten evaluar si se siguen o no las instrucciones farmacológicas y médicas puede utilizarse (42)	Cumplimiento del tratamiento	Horario establecido.	ORDINAL	Alta Media Baja
				Dosis indicadas.		
				Dieta.		
			Implicación personal	Consultas de seguimiento de su tratamiento.		
				Ejercicios físicos indicados.		
				Ajuste de horarios.		
				Tratamiento sin supervisión.		
				Tratamiento sin esfuerzo.		
				Recordatorios, que facilitan el tratamiento.		

	Coordinación entre el paciente y médico, sobre el tratamiento a seguir.
Relación transaccional	Coordinación entre el paciente y médico, de cómo cumplir el tratamiento.
	Aceptación del tratamiento.

Nota: Se muestra la variable; adherencia al tratamiento en personas con TBC. Se muestra, su definición conceptual y operacional, así como sus dimensiones, indicadores, escala de valorativa y escala medición.

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.7.1. Técnica

La técnica utilizada para extraer la información de este estudio fue la encuesta, la cual es aplicar un conjunto de preguntas a los encuestados, con el objetivo de recoger información en una muestra específica, cuyas preguntas bien elaboradas permiten registrar fácilmente las respuestas y registrarlas. (43)

3.7.2. Descripción de instrumentos

Se va a evaluar con el “cuestionario Martin, Bayarre y Grau” se medirá el grado de adherencia al tratamiento, según la puntuación del usuario. Esta encuesta mide tres dimensiones que son; implicación personal, el cumplimiento del tratamiento y la relación transaccional.

El instrumento cuestionario de Adherencia Terapéutica, es un cuestionario cerrado, con preguntas sobre información sociodemográfica y cuestiones relacionadas con el sistema sanitario, el tratamiento, y el paciente. Es necesario que seleccione respuesta “sí” o “no” para estos cuestionarios. (44)

3.7.3. Validación

Se llevará a cabo por destacados docentes expertos, de la universidad

Norbert Wiener:

Dr. Daniel Ñañez Del Pino

Dr. Juan Manuel Parreño Tipian

Dr. Carlos Alfredo Cano Pérez

3.7.4. Confiabilidad

Se debe hallar el coeficiente de Cronbach, que debe encontrarse de cero a uno, para comprobar si el instrumento estudiado es consistente y coherente. Debe mostrarse el intervalo mayor de cero y menor de uno para el coeficiente de Alfa de Cronbach.

Rodríguez “menciona en su artículo de revisión sobre cuestionarios, para medir la adherencia terapéutica farmacológica, al cuestionario de Martin Bayarre y Grau” cumple los requisitos necesarios y tiene estándares fiables para su uso. Destaca también que puede modificarse para abordar diferentes enfermedades crónicas.” (45)

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos

Se realizó el análisis de estudio en el año 2025. En los centros de salud de Lima Centro.

Recolectando y analizando los datos. Con el fin de eliminar las encuestas con errores en las respuestas, como la selección de respuestas múltiples o la elección de no responder a ninguna pregunta, se validaron los cuestionarios cumplimentados por los pacientes tuberculosos. Una vez finalizada ésta, se obtuvieron las hojas de cuestionario admitidas y se prepararon para su mecanografiado.

Las variables y dimensiones se utilizaron para construir la base de las descripciones estadísticas correspondientes en la fase posterior, que consistió en clasificar y agrupar los resultados de los ítems.

Para identificar diferencias significativas estadísticamente entre los resultados esperados y los reales en una o varias categorías, se empleó el método del coeficiente Kuder-Richardson (KR-20) sobre una muestra piloto de 16 personas con tuberculosis atendidas en centros de salud, luego se procedió a codificar las respuestas (Si=1/No=0) con “unos” y “ceros” teniendo en cuenta que las preguntas redactadas en negativo se codificaban de manera inversa.

Se aplicaron herramientas de análisis estadístico haciendo uso del SPSS.
«Statistical Package for the Social Sciences»

3.9. Aspectos éticos

Los aspectos éticos son de gran importancia, ya que su ausencia podría comprometer la integridad de los datos recogidos para el estudio, así como los derechos de propiedad individual e intelectual.

Dado que el plagio está específicamente prohibido por considerarse una violación de la propiedad intelectual, los investigadores cuyos conocimientos se utilizaron en este trabajo recibieron el crédito correspondiente y la referencia bibliográfica adecuada.

Se garantiza que se mantenga la información estrictamente confidencial de la organización que proporcionó sus instalaciones y parte de su personal para el estudio. Para lo cual los resultados fueron para propósitos estrictamente académicos.

Consentimiento informado

Después de coordinar con las personas a cargo del área en el centro de salud, me presenté a cada paciente y les di nuestra información completa (Bachilleres de Farmacia y Bioquímica. Vallejos Díaz, Greisy Vanessa, y León Baldeón Jackeline Daniela). A continuación, les invité a participar en un rápido cuestionario terapéutico y otros factores relevantes.

Se informó al paciente que sólo tardaría unos minutos en completar el cuestionario y que la participación era totalmente voluntaria. A si mismo se explicó a todos los participantes que los datos recopilados no se utilizarían en beneficio propio, sino para la mejoría la atención y el éxito de tratamiento.

IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. Cronograma de actividades

Tabla 3

Cronograma de actividades

ACTIVIDADES	MESES					
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE
Percepción de investigación.	X					
Proposición del problema.	X	X				
Desarrollo de la problemática		X				
Justificación		X	X	X		
Antecedentes			X	X		
Planteamiento de objetivos.				X		
Bases teóricas				X	X	
Hipótesis				X	X	
Metodología de investigación; método, tipo y diseño.					X	X
Población, muestreo, muestra.					X	X
Técnica y herramienta de recolección de datos.						X
Evaluación y fiabilidad de los instrumentos.						X
Estrategias de procesamiento y analítica de datos.						X
Principios Éticos.						X
Gestión de administración.						X
Evaluación del proyecto de investigación.						X
Sustentación de proyecto de investigación.						X

4.2. Presupuesto

Tabla 4

Presupuesto

RECURSOS	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
RECURSOS HUMANOS			
Estadista	300	1	300
SUBTOTAL		300	
MATERIALES DE ESTUDIO			
Hojas de trabajo	0,20	100	10
Dispositivo de Memoria	35	2	70
Impresiones	0.50	200	100
Fotocopias	0,10	400	40
Bolígrafos	1	8	8
Portafolio	3.00	5	15
Cuadernos	3.50	6	21
SUBTOTAL		564	
SERVICIOS			
Movilidad	15	25	375
línea Web	2	90	180
SUBTOTAL		550	
TOTAL		1414	

REFERENCIAS

1. Rodríguez F., Sánchez S. Conocimientos, prácticas y actitudes de enfermería para la atención de personas con tuberculosis. *Enferm. Univer. Revista Internet*. [Online].; 2020 [cited 2021 setiembre 09]; Disponible en : <https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2020.1.713>.
2. Garza-Velasco R, Ávila-de Jesús J, Perea-Mejía L. Tuberculosis pulmonar: la epidemia mundial continúa y la enseñanza de este tema resulta crucial y compleja. *Educación Química*. [Online].; 2017 [cited 2023 nov 19]; Disponible en : <http://www.scielo.org.mx/pdf/eq/v28n1/0187-893X-eq-28-01-00008.pdf>.
3. Rodríguez D. JC. Tuberculosis. *Revista Médica Clínica Las Condes*. [Online].; 2014, [citado 2 marzo 2025]. Disponible en : <https://www.elsevier.es/esrevista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-tuberculosis-S0716864014700690>.
4. Margarit A, Simó S, Rozas L, Deyà-Martínez A, Barrabeig I, Gené A, et al. Tuberculosis en el adolescente; reto y oportunidad de evitar el contagio a la comunidad. *Anales de Pediatría*. [Online]. 2017. Disponible en : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1695403316301151>.
5. Baquero-Artigao F, Del Rosal T, Falcón-Neyra L, Ferreras-Antolín L, Gómez- Pastrana D, Hernanz-Lobo A, et al. Actualización del diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. *Anales de Pediatría*. [Online].2023 [citado 23 marzo 2025] .Disponible en : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1695403323000802>.

6. Culqui D, Munayco E, Grijalva C, Cayla J, Horna-Campos O, Alva Ch. K, et al. Factores asociados al abandono de tratamiento antituberculoso convencional en tratamiento-articulo Perú. Archivos de Bronco neumología. [Online].; 2012 [cited 2022 mayo 1]. Disponible en : <https://www.archbronconeumol.org/es-factores-asociados-al-abandono-S0300289612000075#:~:text=El%20abandono%20del%20tratamiento%20antituberculoso.>
7. Sandoval R, Monteghirfo M, Salazar O, Galarza M. Resistencia cruzada entre isoniacida y etionamida y su alta correlación con la mutación C- 15T en aislamientos de Mycobacterium tuberculosis de Perú. Revista Argentina de Microbiología. [Online].; 2020. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0325754119300495>.
8. Multirresistente diez años después. Medicina Clínica. [Online].; 2021. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025775320308538>.
9. Caminero J, García-García J, Cayla J, García-Pérez F, Palacios J, Ruiz-Manzano J. Tuberculosis con resistencia a fármacos: nuevas definiciones de la OMS y su implicación en la Normativa de SEPAR. Archivos de Bronco neumología. [Online]. 2021.[citado 5 abril 2025]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300289621000880>.
10. Caminero J, García-García J, Caylà J, García-Pérez F, Palacios J, Ruiz-Manzano J. Actualización de la normativa SEPAR “Diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis con resistencia a fármacos.” Archivos de Bronconeumología. [Online].; 2020.Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300289620301010>.
11. Quispe G. Adherencia terapéutica y factores condicionantes en su cumplimiento en pacientes con tuberculosis pulmonar atendidos en la Microred La Palma, Ica diciembre 2017. [Online]. 2018.Disponible en: <https://revistas.unica.edu.pe/index.php/panacea/article/view/37>
12. Cusi, Seras E. Calidad de atención y nivel de adherencia al tratamiento de pacientes con Tuberculosis Pulmonar. Universidad Cesar Vallejo, Ciencias Médicas. Ayacucho: Hospital Regional de Ayacucho. 2018.[citado 6 abril 2025]. Disponible en : https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_17d54cd92b7d320c8ec7aba2d84d2b82
13. Mego Aquije K. Nivel de adherencia al tratamiento de tuberculosis en el centro materno infantil Jose Carlos Mariategui en el año 2021. [Online].; 2021 [cited 2023 octubre 13].

Disponible en : <https://repositorio.upsjb.edu.pe/handle/20.500.14308/3541>.

14. Castro Galarza C, Cama Cristóbal M, Fernández Honorio I, Castro Galarza C, Cama Cristóbal M, Fernández Honorio I. Apoyo familiar y adherencia al tratamiento en personas afectadas de tuberculosis. MediSur. [Online].; 2020. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2020000500869.
- 15- Suescun C. factores relaciones con la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis. Grupo de Investigación del Laboratorio de Salud Pública de Boyacá. Secretaria de Salud de Boyacá. Colombia, 2024.Disponible en: <https://revistas.utp.edu.co/index.php/revistamedica/article/view/25460>
- 16- Muhammad G, Cica M. Relationship between knowledge and medication adherence among patients with tuberculosis: a cross-sectional survey. Bali Medical Journal; 2023.Disponible en : <https://pdfs.semanticscholar.org/507b/60f98186096a477e02aa703f7bb5eb50148e.pdf>
- 17- Sánchez A. Factores asociado a la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis pulmonar en la U.M.F. #15 Cancún Q. Roo. Editorial revista de Ocronos.Medicina interna 2023.Mexico. Disponible en: <https://revistamedica.com/doi-adherencia-tratamiento-tuberculosis-pulmonar/>
- 18- Figueroa C, Jiménez E, Atiz P. Conocimientos, actitudes y prácticas en pacientes con tuberculosis: una revisión sistemática de literatura. Revista RIICS.; 2021.Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/6732/673271835008/html/>
19. Razaq A, Teju A, Olusoji I. Knowledge about tuberculosis, treatment adherence and outcome among ambulatory patients with drug-sensitive tuberculosis in two directly-observed treatment centres in Southwest Nigeria. BMC Public Health. ; 2021.Disponible en : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33827506/>
20. Bacilio S, Romero Y. Adherencia al tratamiento de la tuberculosis en los pacientes atendidos en el centro de salud de Santa Elena. [Online].; 2020 [cited 2025 junio 03]. Disponible en: <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/5241>.

21. Minchan Garcia J, Sandoval Zapata MdP. Factores asociados a la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis pulmonar en el Centro de Salud San Martín de Porres Confraternidad, Lima 2023. [Online].; 2023 [cited 2025 junio 3. Disponible en: <https://repositorio.uma.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12970/1740/TESIS%20MINCHAN-SANDOVAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
22. Berrocal Medina N, Sánchez Cabezas J. Relación entre la adherencia al tratamiento de tuberculosis y el uso de tecnologías de información y comunicación en 02 establecimientos de salud de la DIRIS Lima Norte, 2021. [Online].; 2023 [cited 2025 junio 3. Available from: https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/13561/Relacion_BerrocalMedina_Nicole.pdf?sequence=6&isAllowed=y.
23. Quispe Muñoz D, Ríos Quispe I. Factores de riesgo asociados al abandono del tratamiento de tuberculosis en los pacientes de la Red, Pacasmayo. [Online].; 2024 [cited 2025 junio 03. Available from: <https://dspace.unitru.edu.pe/server/api/core/bitstreams/5320972d-1ee4-42b2-82c4-94803eaf5824/content>.
24. Quispe Mendoza S. Conocimiento y actitud hacia la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis pulmonar en un centro de salud de Lima, 2024. [Online].; 2024 [cited 2025 abril 5. Available from: <https://repositorio.uwiener.edu.pe/server/api/core/bitstreams/34bdc418-f12e-4a7c-a4b5-230c56446403/content>.
25. Organización Mundial de la Salud. Tuberculosis. [Online].; 2025. Available from: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis>.
26. Scielo Perú. Seroprevalencia de infección por Helicobacter pylori en población adulta de Lima, Perú 2017. [Online].; 2017. Available from: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-558X2017000200009.
27. Manual MSD. Tos en adulto. [Online].; 2023. Available from: <https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-del-pulm%C3%B3n-y-las-v%C3%ADas-respiratorias/s%C3%ADntomas-de-los-trastornos-pulmonares/tos-en-adultos>.
28. MINSA. Asegurados con tuberculosis reciben atención gratuita gracias a la cobertura del SIS. [Online].; 2024. Available from: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1131831-minsa-asegurados-con-tuberculosis-reciben-atencion-gratuita-gracias-a-la-cobertura-del-sis>.

29. NIH. Medicamentos antituberculosos. [Online].; 2023. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557666/>.
30. Manual MSD. Reacciones adversas a los fármacos. [Online].; 2025. Available from: <https://www.msdmanuals.com/es/professional/farmacolog%C3%ADa-cl%C3%ADnica/reacciones-adversas-a-los-f%C3%A1rmacos/reacciones-adversas-a-los-f%C3%A1rmacos?ruleredirectid=758>.
31. Minchan Garcia J, Sandoval Zapata MdP. Factores asociados a la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis pulmonar en el Centro de Salud San Martín de Porres Confraternidad, Lima 2023. [Online].; 2023 [cited 2023 agosto 24. Disponible en: <https://repositorio.uma.edu.pe/handle/20.500.12970/1740>.
32. Ibarra Barrueta O, Navarro Ruiz A. Definición e Importancia de la Adherencia. [Online].; 2017. Disponible en: https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/Adherencia2017/libro_ADHERENCIA.pdf.
33. Carranza Paucar G. Cascada de cuidado de la tuberculosis latente en dos establecimientos de salud de primer nivel de atención de Lima Sur, 2016-2018. [Online].; 2022. Disponible en: <https://repositorio.uma.edu.pe/browse?type=author&value=Carranza+Paucar%2C+Grecia>
34. EUPATI. Factores de riesgo en la salud y la enfermedad. [Online].; 2015. Disponible en: <https://toolbox.eupati.eu/resources/factores-de-riesgo-en-la-salud-y-la-enfermedad/?lang=es>.
35. Parana Huaymacari T, Alcántara Guerrero L. Autocuidado en pacientes con tuberculosis pulmonar en el Centro de Salud Portada de Manchay, Pachacamac 2022. [Online]; 2022. Disponible en : https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UMAI_aad4324ec0a981249c28ff549549fd6c
36. Mendoza Licito M, Mendoza Licito M. Estilos de afrontamiento en pacientes con tuberculosis atendidos en el centro de salud los libertadores, San Martín de Porres 2022. [Online].; 2022. Disponible en : <https://repositorio.uma.edu.pe/handle/20.500.12970/1083>.
37. López Roldán P, Fachelli S. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL CUANTITATIVA. [Online].; 2015. Available from: https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2020/232105/metinvsoccua_cap1-1a2020.pdf.
38. Hernández Sampieri R. Metodología de la Investigación. [Online].; 2018. Available from: <https://www.esup.edu.pe/wp->

<content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf>.

39. Scielo. Estudios de Corte Transversal. Un Diseño de Investigación a Considerar en Ciencias Morfológicas. [Online].; 2023. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022023000100146.
40. Caro L. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos. [Online].; 2020. Disponible en: https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25172w/M1CCT05_S3_7_Tecnicas_e_instrumentos.pdf.
41. Palacin Custodio ML. Adherencia a la terapia farmacológica y sus factores asociados en pacientes con tuberculosis del programa de TBC en un centro de Salud de Lima Metropolitana 2021. [Online].; 2021. Disponible en: <https://repositorio.uwiener.edu.pe/server/api/core/bitstreams/942015db-d246-476d-964b-d89aa04849e7/content>.
42. Pharmaceutical. Revisión de test validados para la valoración de la adherencia al tratamiento farmacológico utilizados en la práctica clínica habitual. [Online].; 2020. Disponible en: <file:///C:/Users/Maria/Downloads/mcolomer,+REVISION-572-DEF.pdf>.
43. Mg. Aquino N, Lic.Figueroa J, vallejos V, Robles Lic. Huillca J. documento técnico: “análisis de la situación de salud hospitalaria”. [online]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7294950/6233819-analisis-de-la-situacion-de-salud-hospitalaria-2024.pdf>.
44. Hernández Martín Z. Métodos de Análisis de Datos. [Online].; 2012. Disponible en: https://www.unirioja.es/cu/zehernan/docencia/MAD_710/Lib489791.pdf.
45. ESAN. La importancia de la ética en la toma de decisiones. [Online].; 2019. Disponible en: <https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/la-importancia-de-la-etica-en-la-toma-de-decisiones>.

ANEXOS

ANEXO. Matriz de consistencia

Título de la investigación: Factores relacionados y adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud. Lima Centro. 2025

Formulación del problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Diseño metodológico
Problema general ¿Qué relación existe entre los factores relacionados y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud Lima Centro 2025?	Objetivo general Determinar la relación que existe entre los factores relacionados y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud.	Hipótesis general Existe relación entre los factores relacionados y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud.	Variable 1 Dimensiones: Tipo de investigación Factores relacionados Variable 2 Dimensiones:	Trabajo investigado es básico
Problemas específicos - ¿Qué relación existe entre los factores relacionados al sistema de asistencia sanitaria y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud? - ¿Qué relación existe entre los factores relacionados al tratamiento y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud? - ¿Qué relación existe entre los factores relacionados al paciente y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud? - ¿Qué relación existe entre los factores relacionados en personas con tuberculosis en centros de salud?	Objetivos específicos -Establecer la relación entre los factores relacionados al sistema de asistencia sanitaria y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud. -Establecer la relación entre los factores relacionados al tratamiento y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud. -Establecer la relación entre los factores relacionados al paciente y la adherencia tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud.	Hipótesis específica ●Existe relación entre los factores relacionados al sistema de asistencia sanitaria y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud. ●No existe relación entre los factores relacionados al sistema de asistencia sanitaria y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud. ●Existe relación entre los factores relacionados al tratamiento y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud. ●No existe relación entre los factores relacionados al tratamiento y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud. ●Existe relación entre los factores relacionados al paciente y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud. ●No existe relación entre los factores relacionados al paciente y la adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud.	Adherencia al tratamiento en. personas con tuberculosis	Método y diseño de la investigación Diseño: No experimental Corte: Transversal Nivel: Correlacional Población y muestra La población en el presente trabajo investigado se encontró conformada por 120 pacientes con tratamiento TBC

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS

CUESTIONARIO DE “FACTORES RELACIONADOS Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PERSONAS CON TUBERCULOSIS”.

El presente cuestionario, es anónimo y confidencial, está elaborado para recabar información sobre factores relacionados y adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis. Marque con un aspa (X) en la casilla que considere pertinente. Se agradece por anticipado su participación

Autoras: Leon Baldeon ,Jackeline Daniela.
Vallejos Diaz, Greisy Vanessa

Cuestionario de Factores relacionados a la adherencia al tratamiento.				
Factores socioeconómicos				
Género: (M) (F)				
Edad: _____				
Escolaridad: a) Primaria –b) Secundaria – c) Superior				
Estrato económico: a) Bajo –b) Medio – c) Alto				
PREGUNTAS			Alternativas	
			Si	No
A. Sistema de Asistencia Sanitaria				
1	¿El médico lo orienta sobre el tratamiento que está llevando para su enfermedad?			
2	¿EL médico le responde a sus inquietudes sobre la medicación?			
3	¿Existe completo abastecimiento de los medicamentos?			
B. Tratamiento				
4	¿Toma muchos medicamentos?			
5	¿Sus medicamentos son proporcionados por el seguro de Salud?			

6	¿Ha comprado los medicamentos para su tratamiento en algún momento?		
7	¿Conoce que' efectos indeseados puedan ocasionar los medicamentos que consume?		
8	¿Ha tenido que interrumpir su tratamiento no contar con los medicamentos?		
9	¿Ha sentido malestar al tomar su medicación?		
C	Paciente		
10	¿Considera que no debe tomar los medicamentos para tratar su enfermedad?		
11	¿Siente motivación a cumplir con el tratamiento?		
12	¿Presenta depresión por presentar la enfermedad?		
13	¿Considera que por la enfermedad tiene limitaciones en sus actividades diarias?		
14	¿Debido a la enfermedad, nota cambios en su estilo de vida?		
15	¿Conoce la dieta que debe seguir, la cual debe ir de la mano con su tratamiento?		
16	¿Cuenta con apoyo familiar?		
17	¿Está integrado en algún programa para pacientes, que reciben apoyo en el tratamiento?		
18	¿El Centro de Salud al que usted pertenece, queda lejos de su casa?		

Cuestionario de Adherencia al Tratamiento en personas con Tuberculosis			
Preguntas		Alternativas	
		SI	NO
A. Cumplimiento del Tratamiento			
19	¿Toma la medicación en el horario correspondiente?		
20	¿Cumple con la dosis indicada por el médico?		
21	¿Cumple las indicaciones del médico para su dieta?		
22	¿Acude a sus consultas pactadas?		
B. Implicación Personal			
23	¿Realiza los ejercicios físicos indicados por el médico?		
24	¿Ajusta su horario para cumplir con la medicación?		
25	¿Cumple el tratamiento sin supervisión de su familia ó amigos?		
26	¿Cumple con el tratamiento sin esfuerzo?		
27	¿Emplea recordatorios que faciliten cumplir con la medicación?		
C.Relación Transaccional			
28	¿Acuerda con su médico el tratamiennto a seguir?		
29	¿Comprendió a su médico como va a cumplir el tratamiento?		
30	¿Manifiesta la aceptación del tratamiento?		

Anexo 3 : Validez del Instrumento

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador. Dr. Carlos Alfredo Cano Pérez, Dr. Daniel Ñañez Del Pino, Dr. Juan Manuel Parreño Tipian

Especialidad del validador: Doctor en Farmacia y Bioquímica

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

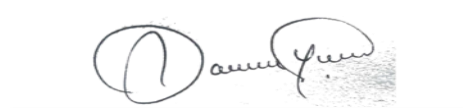
³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

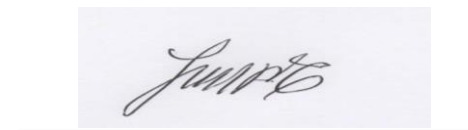
26 de Julio del 2025.



Firma del Experto Informante
Dr. Carlos Alfredo Cano Pérez



Firma del Experto Informante
Dr. Daniel Ñañez Del Pino



Firma del Experto Informante
Dr. Juan Manuel Parreño Tipian

COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

Lima, 14 de agosto del 2025.

Autor Responsable:

JACKELINE DANIELA LEON BALDEON

Exp. N°: 2013-2025

Es grato expresarle mi cordial saludo y a la vez informarle que el Comité Institucional de Ética e Integridad Científica de la Universidad Privada Norbert Wiener (CIEIC-UPNW) evaluó y **APROBÓ** el siguiente proyecto de investigación:

Proyecto Titulado: "FACTORES RELACIONADOS Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PERSONAS CON TUBERCULOSIS EN CENTROS DE SALUD.LIMA CENTRO.2025"
Versión Nro.1, con fecha 11/08/2025.

El cual tiene como Autor(es) a:

JACKELINE DANIELA LEON BALDEON
GREISY VANESSA VALLEJOS DIAZ

La **APROBACIÓN** comprende el cumplimiento de las buenas prácticas éticas, el balance riesgo/beneficio, la calificación del equipo de investigación y la confidencialidad de los datos, entre otros.

El investigador deberá considerar los siguientes puntos detallados a continuación:

- La **vigencia** de la aprobación es **24 meses** a partir de la emisión de este documento.
- Toda **enmienda** deberá presentarse al CIEIC-UPNW; el proyecto no podrá ejecutarse sin su aprobación previa.
- La constancia de aprobación por el CIEIC **no garantiza** la **aceptación** por parte de las **instituciones** donde pretende ejecutar el trabajo de investigación.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Mg. Angelica Karina Minaya Galarreta
Presidente
Comité Institucional de Ética e Integridad Científica
Universidad Privada Norbert Wiener

CONSENTIMIENTO INFORMADO EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

Institución: Universidad Privada Norbert Wiener

Investigadores: Jackeline Leon Baldeon
Greisy Vallejos Diaz

Título: “FACTORES RELACIONADOS Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PERSONAS CON TUBERCULOSIS EN CENTROS DE SALUD.LIMA CENTRO.2025”

Propósito del estudio

Lo invitamos a participar en un estudio llamado: “FACTORES RELACIONADOS Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PERSONAS CON TUBERCULOSIS EN CENTROS DE SALUD.LIMA CENTRO.2025”. Este es un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Privada Norbert Wiener, Jackeline Leon Baldeon y Greisy Vallejos Diaz. El propósito de este estudio es Determinar la relación que existe entre la adherencia al tratamiento y los factores relacionados en personas con tuberculosis atendidas en centros de salud de Lima 2025.

Su ejecución ayudará a/permitirá a la contribución a fortalecer el conocimiento de los pacientes sobre su enfermedad. Mejorar su actitud ante el tratamiento y facilitar el cumplimiento de este mismo, promoviendo así una mejora calidad de vida.

Procedimientos:

Si usted decide participar en este estudio, se le realizará lo siguiente:

- Al aceptar de manera voluntaria la encuesta pasara a completar sus datos, edad, genero, escolaridad, estrato económico y marcar las respuestas.
- La encuesta puede demorar unos 15 minutos
- Los resultados del cuestionario se le entregara a Usted en forma individual o almacenaran respetando la confiabilidad y el anonimato.

Riesgos:

Su participación en el estudio no tiene ningún riesgo, ya que sus respuestas se mantendrán de forma anónima.

Beneficios:

Usted se beneficiará ya que con la información obtenida en el estudio ayudará, para que se pueda trabajar en los puntos críticos obtenidos de los resultados, y evitar el riesgo que pueda tener la falta de adherencia al tratamiento de la tuberculosis.

Costos e incentivos:

Usted no deberá pagar nada por la participación. Tampoco recibirá ningún incentivo económico ni medicamentos a cambio de su participación

Confidencialidad:

Nosotros guardaremos la información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita su identificación. Sus archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio.

Derechos del paciente:

Si usted se siente incómodo durante la encuesta, podrá retirarse de este en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno. Si tiene alguna inquietud o molestia, no dude en preguntar al personal del estudio. Puede comunicarse con los investigadores: Jackeline Leon Baldeon con número telefónico: 937075409 o con Greisy Vallejos Diaz con número de teléfono: 957785464 o al comité que validó el presente estudio, Dra. Yenny M. Bellido Fuentes, presidenta del Comité de Ética para la investigación de la Universidad Norbert Wiener, tel. +51 924 569 790. *E-mail:* comité.etica@uwiener.edu.pe

CONSENTIMIENTO

Acepto voluntariamente participar en este estudio. Comprendo qué cosas pueden pasar si participo en el proyecto. También entiendo que puedo decidir no participar, aunque yo haya aceptado y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. Recibiré una copia firmada de este consentimiento.

Participante

Nombres:

DNI:

Investigador

Nombres: Jackeline Leon Baldeon

DNI: 45847355

Investigador

Nombres: Greisy Vallejos Diaz

DNI: 46746892



Universidad
Norbert Wiener

COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD CIENTÍFICA

APROBACIÓN DE ENMIENDA

Lima, 18 de octubre del 2025.

Autor Responsable:

Jackeline Daniela Leon Baldeon

Exp. Nº: 2013-2025

De mi consideración:

El Comité Institucional de Ética e Integridad Científica (CIEIC) de la Universidad Privada Norbert Wiener, tras evaluar la solicitud presentada, **APRUEBA LA ENMIENDA** del proyecto, originalmente titulado "Factores relacionados y adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud. Lima. 2025" Versión 01 con fecha 28/05/2025. El detalle de la enmienda se consigna en la sección "Cambios aprobados"; de ser el caso, se incorpora el nuevo título.

Autor(es):

Jackeline Daniela Leon Baldeon

Greisy Vallejos Diaz

Cambios aprobados:

Se modifica la redacción del título: "Factores relacionados y adherencia al tratamiento en personas con tuberculosis en centros de salud. Lima-Centro. 2025".

Alcance de la aprobación:

La aprobación de enmienda confirma que las modificaciones cumplen con las buenas prácticas éticas y no alteran el balance riesgo/beneficio, la idoneidad del equipo de investigación ni la confidencialidad de los datos previamente evaluados.

Obligaciones del investigador

- Esta aprobación no amplía ni modifica la vigencia otorgada en la constancia de aprobación inicial del proyecto; esta se mantiene en todo lo no modificado por la enmienda. Asimismo, los cambios rigen desde la fecha de emisión.
- Para fines administrativos o académicos, debe presentar ambos documentos: la constancia de aprobación del proyecto y la constancia de aprobación de enmienda. Cualquier cambio adicional requiere nueva evaluación del CIEIC.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Mg. Angélica Karina Millaño Galante
Presidenta
Comité Institucional de Ética e Integridad Científica
Universidad Privada Norbert Wiener